ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
KHOA CẤP CỨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MS: 52/BV02

BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

I. HÀNH CHÍNH

Họ và tên *(In hoa)*: NGUYỄN TUYẾT HẠNH Ngày sinh: 20/07/1953 Tuổi: 71

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: 343/15 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Số thẻ BHYT: HT3790100047288

Số Căn cước/Hộ chiếu/Mã định danh cá nhân: 046153006849

Vào viện ngày: 24/12/2024 12:11 Ra viện ngày: 24/12/2024 23:28

Số hồ sơ: N24-0364075 Số nhập viện: 25-0001102

II. CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán vào viện:

Theo dõi ung thư chưa rõ nguyên phát di căn gan đa ổ, màng phổi trái, màng ngoài tim, khả năng từ đại - trực tràng (C18.9); Đa polyp đại tràng lên, sigma, trực tràng, nậu môn đã cắt trọn qua nội soi (17/12/2024) (GPB: U tuyến ống) (K63.5); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21.9); Viêm dạ dày (K29.6)

Chẩn đoán ra viện:

Thuyên tắc bán phần động mạch phổi phải nhánh phân thùy S9, S10 (I26.9); Tràn dịch màng ngoài tim nghĩ trong bệnh ác tính (I31.3); K phổi trái (giai đoạn T4N3M1) di căn xương, di căn gan đa ổ, hạch ổ bụng (C34.9); Đa polyp đại tràng lên, sigma, trực tràng, hậu môn đã cắt trọn qua nội soi (17/12/2024) (GPB: U tuyến ống) (K63.5); Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (K21.9); Viêm dạ dày (K29.6); Thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc mức độ nhẹ (D50.0)

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

Lý do vào viện:

Mệt mỏi

Tóm tắt quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng

- Bệnh sử:

  Bệnh sử: Bệnh nhân khai bệnh:
  Cách nhập viện 2 tuần, bệnh nhân thường mệt mỏi, khó thở, không liên quan tư thế, giảm khả năng gắng sức, đau nặng ngực trái, lan lưng, đau thượng vị và quanh rốn, đau từng cơn, tiêu phân vàng, buồn nôn, nôn ít, hay ợ hơi, đầy hơi, đến khám Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược quận 10 17/12/2024, đã nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng, ghi nhận đa polyp, sinh thiết trọn, cho toa về đính kèm hồ sơ.
  Ngày nhập viện, bệnh nhân tái khám phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược quận 10, còn mệt mỏi, nặng ngực nên khám thêm Tim mạch, có siêu âm tim ghi nhận tràn dịch màng ngoài tim (bề dày #10mm), XQ ghi nhận tràn dịch màng phổi trái nên chuyển cơ sở 1.

- Tóm tắt diễn tiến

Ngày	Diễn biến lâm sàng	Phương pháp điều trị
	Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được Niêm hồng Tần số tim: 98 l/p, Huyết áp: 110/70 mmHg, Nhịp thở:18 l/p, Nhiệt độ: 36.4 °C, SpO2: 94 % Thở khí phòng Không phù chân. Nằm 1 gối. Tim đều Phổi không ran Bụng mềm, ấn đau quanh rốn, chướng nhẹ, nhu động ruột (+) Cổ mềm. Sức cơ 5/5 đều.	Xử trí thuốc ban đầu Chỉ định cận lâm sàng

Tiền sử bệnh:

Tiền căn:
+ GERD - Viêm dạ dày
+ Không ghi nhận bệnh mạn tính khác
- Tiền sử dùng thuốc 24h qua: Toa đính kèm
- Dị ứng: chưa ghi nhận

O
Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được
Niêm hồng
Thở khí phòng.
Không phù chân. Nằm 1 gối.
Tim đều
Phổi không ran
Bụng mềm, ấn đau quanh rốn, chướng nhẹ, nhu động ruột (+)
Cổ mềm. Sức cơ 5/5 đều.

Những dấu hiệu lâm sàng chính được ghi nhận

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được
Niêm hồng
Thở khí phòng.
Không phù chân. Nằm 1 gối.
Tim đều
Phổi không ran
Bụng mềm, ấn đau quanh rốn, chướng nhẹ, nhu động ruột (+)
Cổ mềm. Sức cơ 5/5 đều.

Tóm tắt kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán

- Xét nghiệm:

  WBC: 10.0 10^9 /L, NEU %: 72.0 % N, Hb: 105 g/L, MCV: 66.1 fL, MCH: 21.1 pG, PLT: 274 10^9/L

- Chẩn đoán hình ảnh:

CTscan ngực:
- Khối choán chỗ thùy trên phổi trái, nghĩ K, giai đoạn T4N3M1.
- Vài nốt đặc rải rác hai phổi nghĩ nốt thứ phát.
- Nhiều nốt đặc xương rải rác thân đốt sống ngực, xương sườn, xương ức, xương vai trái, nghĩ tổn thương thứ phát.
- Huyết khối bán phần động mạch phổi phải nhánh phân thùy S9, S10.
- Tràn dịch màng ngoài tim.
- Vài nhân giáp thùy trái.

CTscan bụng
- Tổn thương gan đa ổ, nghĩ thứ phát.
- Nhiều hạch dọc động mạch chủ bụng, theo dõi hạch thứ phát.
- Thoái hóa + vẹo trái cột sống thắt lưng.
- Nhiều ổ đặc xương rải rác các đốt sống thắt lưng, xương chậu, xương đùi trái, nghĩ tổn thương thứ phát.

Phương pháp điều trị

khoa:

hương pháp điều trị: Nội khoa

Các thuốc chính đã sử dụng:
Esomeprazol 40mg 01 lọ tiêm tĩnh mạch, Glucose 10% 500ml 01 chai truyền tĩnh mạch, Enoxaparin 6000 UI tiêm dưới da lúc 22h30 ngày 24/12/2024

- Bác sĩ điều trị: ThS BS. Nguyễn Thị Kim Ngân
- Phẫu thuật, thủ thuật

Tình trạng ra viện:

- Tình trạng người bệnh khi ra viện: Đỡ, giảm
- Vấn đề cần theo dõi thêm: Xuất huyết, tri giác, sinh hiệu

Hướng điều trị và các chế độ tiếp theo

- Lời dặn: (Xuất viện theo yêu cầu)
  Đề nghị nhập viện

Ngày 24 tháng 12 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

BS. Nguyễn Khánh Lương
A17-027

TRƯỞNG KHOA

BS.CKI. Nguyễn Anh Kiệt
A21-094

Tham khảo bản điện tử, kết quả cận lâm sàng - chẩn đoán hình ảnh tại app UMC CARE. Tham khảo chứng thực chữ ký số và các văn bản chấp thuận triển khai chữ ký số của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội TPHCM tại **https://hsdt.umc.edu.vn**